

 ПРОСТРАНСТВО НОВЫХ ИДЕЙ 2.0

КРАТКАЯ ВЕРСИЯ · ВЕЧЕР ЧТЕНИЯ

Не просто накормить

Как организовать безопасное, достойное и вариативное питание людей с психическими нарушениями в домах социального обслуживания

Суть · лестница вариативности · красные линии · пилот на 90 дней · панель пяти чисел

Дискуссия «Организация питания: опыт реализации проектов» · 26.08.2026, 14:00–15:30

Площадка № 2 — ДСО «Тесовый берег» · модераторы: Чистяков Е. В., Нурбаев Т. А.

Чистяков Е. В., директор СПб ГАСУСОН «ДСО „Серафимовский“» · версия 1.0

Для кого это и как читать

Это выжимка полного методического руководства (250 страниц, 45 приложений) для руководителя стационарной организации социального обслуживания, у которого есть один вечер. Полная версия — «Не_просто_накормить_доклад» (четыре формата PDF в 01_доклад/ репозитория); устный формат — презентация дискуссии «Организация питания: опыт реализации проектов» (26.08.2026, площадка № 2 — ДСО «Тесовый берег»).

Контекст: одинакового питания не бывает. Меню в документах одно, а за столом сидят люди с разной способностью глотать, разной чувствительностью к лекарствам, разной историей еды и разным правом выбрать. Доклад отвечает на вопрос, как организовать выбор блюд так, чтобы это было безопасно клинически, законно юридически и исполнимо на обычной кухне.

Суть в пяти тезисах

1. Одинаковое меню ≠ одинаково доступное питание. Житель с дисфагией не может безопасно проглотить то, что глотает сосед; житель на клозапине не должен запивать обед грейпфрутовым соком; неговорящий не сможет заказать «второе». Учёт «выдано по норме» этого не видит.

2. Выбор уже разрешён законом. Ни один федеральный акт не запрещает вариативное меню; таблицы замены продуктов в раскладках — существующий легальный механизм. Запрет появился бы не из норм, а из привычки.

3. Выбор живёт внутри безопасного диапазона. Достоинство и безопасность — не противоположности: «два безопасных варианта» вместо «одного назначенного» решает оба конфликта сразу. Границу диапазона проводит врач (текстуры, противопоказания, диеты).

4. Вариативность начинается не с кухни, а с замера. Семь дней измерений — ночной интервал, несъеденное, фактические замены — стоят ноль рублей и меняют всё понимание проблемы.

5. Результат проверяется фактами, а не меню в папке. Фактический выбор жителей, съеденное, безопасность (поперхивания, отказы), жалобы — четыре числа, которые показывают, работает ли система.

Правовая рамка в одну страницу

- **Закон 3185-1** «О психиатрической помощи»: ст. 5 (гуманное отношение, достоинство), ст. 37 (права пациентов стационаров), ст. 43 (те же права — проживающим ПНИ/ДСО), ст. 11 (согласие на медицинское вмешательство — касается диет, не выбора блюда);
- **442-ФЗ** «Об основах социального обслуживания»: ст. 9 (права получателя), ст. 16 (ИППСУ — «исходя из потребности гражданина»), ст. 32 ч. 4 (плата за стационар ≤ 75 % дохода);
- **СанПиН 2.3/2.4.3590-20** п. 7.1.11 → с 01.09.2026 **СанПиН 2.3/2.4.4282-26** п. 56(11): не менее 3 приёмов пищи, диетическое по показаниям — число вариантов не ограничено;
- **Приказ Минтруда 520н** от 13.09.2022: рекомендуемые нормы питания стационара (уточнять региональный акт — в СПб это постановление № 1284);
- **Приказы Минздрава 330 и 395н**: лечебное питание — для медицинских организаций; в СОСО диета — по назначению врача;
- **ГК РФ** ст. 29–30: недееспособность/ограниченная дееспособность; выбор блюда — не сделка и не медвмешательство;
- **КоАП ст. 6.6**: ответственность за санитарные нарушения в организации питания — контур качества и безопасности, не числа блюд.

Почему это про жизнь и смертность, а не про кухню

Разрыв смертности людей с тяжёлыми психическими расстройствами с общей популяцией — 15–20 лет, и существенная часть этого разрыва происходит за столом: метаболические эффекты антипсихотиков (прибавка веса до +3 кг за шесть недель в зависимости от препарата), расстройства глотания у 22–70 % проживающих, аспирационные пневмонии со смертностью в семь раз выше популяционной. Ночной интервал «ужин в 17:30 — завтрак в 8:30» (15 часов без еды) усугубляет и вес, и поведение. Организация стола — это первая линия профилактики, а не «бытовая услуга».

Шесть вопросов дискуссии — короткие ответы

1. Кто выбирает форму питания — проживающий или руководитель? Права принадлежат жителю (ст. 5, 37, 43 закона 3185-1; ст. 9 442-ФЗ); учреждение — организатор условий выбора, а не собственник воли. Документируйте выбор (журнал, пищевые карты) — тогда для проверяющего это система, а не отступление от раскладки. Модель «шеф решает, что готовить; житель решает, что взять из предложенного» — рабочая и не требует ресторана.

2. Как формировать меню в условиях жёстких ограничений? Нормы ограничивают набор продуктов, но не число тарелок: пары эквивалентов (гречка/рис, курица/индейка) внутри одной раскладки законны и стоят копейки; настоящая цена — труд и порядок (журнал заказа, вторая гастрорёмкость, обучение смены).

3. Должно ли питание быть «лечебным»? В общем случае — нет: приказы о лечебном питании адресованы медицинским организациям. Обычное питание + диетическое поимённо по назначению врача. «Лечебность» руками кухни — риск здоровью и проверкам.

4. Как совместить «лечебное» и «вариативное»? Врач задаёт рамку (стол, текстура), внутри рамки — пары эквивалентов. Диета ограничивает множество блюд, а не сжимает его до одного. Журнал замен фиксирует каждый выбор — это защита и жителя, и врача; статистика выбора раз в квартал корректирует меню-цикл.

5. Баланс выбора недееспособного и медицинских рекомендаций? Выбор блюда — не медицинское вмешательство: воля выявляется показом двух порций, наблюдением, пищевой биографией, «теми, кто знает». Медицинские назначения сужают выбор до безопасного, но не отменяют его.

6. Качество против нормирования цен? Полная стоимость обеда в 3–6 раз выше сырьевой строки: нормируя цену порции, управляем меньшей частью денег. Теряют не на белке, а на отходах, срывах поставок и наценках — работать нужно с закупочной процедурой и замером отходов. Качество закладывается в техзадание до торгов (ГОСТы, жирность, упаковка), а не «чем дешевле».

Шесть измерений одного стола

«Накормлен ли житель» — не один вопрос, а шесть: (1) **безопасно** — текстура, глотание, лекарственные конфликты; (2) **доступно** — понятно ли предложение, может ли выбрать неговорящий; (3) **выбрано** — дошла ли воля жителя до тарелки; (4) **достаточно** — белок, калорийность, вес; (5) **удобно** — время, место, помощь, посуда; (6) **достойно** — как подано и как названо. Мономеню проваливается не в первом измерении («выдано по норме»), а во всех остальных — и именно поэтому учёт его не видит.

Лестница вариативности

Ступень 0 — мономеню с учётом отказов · 1 — выбор из двух в одной позиции · 2 — выбор по всем позициям · 3 — шведская линия · 4 — семейная подача · 5 — своя кухня. Ступени 1–2 подтверждены публичной практикой 2024–2026 (Новосибирская и Иркутская области, Санкт-Петербург); 3–5 — горизонт, а не требование. Вторая ось — участие: дошёл ли выбор жителя до тарелки (0–5, от «выбора нет» до «еда снова часть жизни»). Проект поднимается сразу по двум осям; ступень выбирают по жителю, а не по бюджету.

Красные линии: что нельзя без других

Без врача: любые ограничения рациона (включая «диабетический стол»), изменение текстур, правила при дисфагии, действия при длительном отказе от еды, решения об энтеральном питании, сдвиг времени еды у жителей на инсулине.

Без учредителя: изменение финансирования продуктовой строки, штатного расписания, аутсорсинг питания, официальный статус и публичность пилота.

Без правовой проверки: формулировки о «согласии недееспособного» в локальных актах, обработка пищевых карт как персональных данных, ситуации, где учреждение одновременно является опекуном жителя.

Международные ориентиры (не нормы РФ)

Скрининг статуса питания **MUST** — пять минут силами медсестры, приоритет и план действий по риску. Шкала текстур **IDDSI** — общий язык для врача, кухни и смены при дисфагии; обучение смены в пилотных учреждениях поднимало соответствие текстур с 44 до 90 %. Немецкая модель **Wunschkost** («еда по желанию») и протоколы комфортного кормления в конце жизни — то, к чему ведут верхние ступени лестницы. Использовать как ориентиры, а не как требования проверяющих.

Минимальная безопасная модель

Если ресурсов на пилот нет — стройте фундамент: (1) документы и журналы ведутся фактически, а не «задним числом»; (2) лекарственно-пищевая таблица на посту, список группы дисфагического риска у сиделки, правило «три отказа подряд → врач в тот же день»; (3) на каждого кормимого — конкретный помощник; (4) ежемесячный разбор остатков и хотя бы один канал пожеланий жителей; (5) ночной интервал и отходы известны числом. На этом фундаменте пилот ставится за квартал; без него — опасен.

Пилот на 90 дней

Дни 1–30 — измерение: семидневный замер отходов и ночного интервала; аудит одного обеда; опрос предпочтений; baseline-числа заносятся в панель.

Дни 31–60 — документы и люди: положение о вариативном питании, пары эквивалентов с врачом, обучение смены (15 минут), журналы заказа и замен, согласование с учредителем «для сведения».

Дни 61–90 — пилот: одно отделение, завтрак и обед, две позиции на выбор, стандартный вариант гарантирован. Ежедневный журнал фактического выбора; правило трёх отказов; итог против baseline.

Что уже делают в России: четыре публичных кейса

Болотнинский и Успенский ПНИ (Новосибирская обл., 2024). Старт — «два вторых блюда» на линии; в Успенском — шведская линия с отдельной зоной диетических блюд для диабетиков и ЖКТ. Пример того, как вариативность начинается без новых денег: внутри существующей раскладки.

Иркутская область (2024–2025). От опроса предпочтений в Усть-Илимском ДСО — к региональному решению для всех стационарных учреждений: масштабирование инициативы на уровень учредителя.

ДСО «Серафимовский» (Санкт-Петербург, 2025–2026). Заказ рациона на следующий день; старт потребовал оборудования и ставок — об этом сказано публично. Развитие: приказ № 124 от 10.03.2026 утвердил правила внутреннего распорядка жителей, и заказное питание (вариативное меню) закреплено в них как норма — включая маломобильных граждан (приём пищи в жилых комнатах, помощь в кормлении). Выбор стал не экспериментом, а правилом дома.

Общее у всех кейсов: точка входа — предпочтения, а не меню; скромная первая конфигурация; публичность как защита; честное называние пределов. «Бесплатного полного перехода» не обещал никто — и это правильная рамка ожиданий.

Что меняется 1 сентября 2026

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 заменяется СанПиН 2.3/2.4.4282-26 (постановление от 02.06.2026 № 18), переходного периода нет. Что сделать до 31.08: перепривязать положение о питании, формы журналов (приложения 4–5 нового СанПиН — журналы бракеража), ППК и ХАССП; журналы, заполненные до 31.08, законны как есть — задним числом не переписывать. Главное: число вариантов блюда не ограничено ни в одной редакции правил — вариативность не конфликтует ни со старым, ни с новым СанПиН.

Частые вопросы руководителя

«А если проверка придёт?» Проверяют не число блюд, а безопасность и документальный контур: пробы каждого варианта, бракераж, журнал выбора, назначения врача. Вариативность с журналом выглядит системой; мономеню без журналов — нет.

«Где взять деньги?» Ступени 1–2 укладываются в существующую раскладку (пары эквивалентов стоят копейки на порцию); полная стоимость обеда в 3–6 раз выше сырьевой строки, поэтому настоящая экономия — отходы и закупочная процедура, а не белок в тарелке.

«У нас особые жители, никто не выберет». Выбор выражается не только словом: показ двух порций, взгляд, жест, привычка всей жизни. Для неговорящих работают ровно те же журналы — с отметкой об источнике выбора.

«Персонал и так перегружен». Поэтому пилот — одно отделение и две позиции, а не весь дом сразу. Журнал заказа — тетрадь. Замер — одна страница в день.

«Кухня не своя — подрядчик». Вариативность живёт в контракте: группы позиций, гарантия двух вариантов, замены, текстуры, пробы, отчётность. Пробы и ответственность остаются у учреждения.

Минимальный комплект документов

1. Положение об организации питания с описанием модели выбора; (2) меню с парами эквивалентов; (3) журнал заказа/выбора блюд; (4) журнал замен; (5) пищевые карты жителей (биография, ограничения, источник выбора); (6) карта лечебного питания по назначениям врача; (7) протокол совета жителей о модели. Шаблоны — приложения 1–45 полного руководства.

Панель пяти чисел (что измерять всегда)

1. **Ночной интервал** ужин→завтрак, часы (цель — меньше 12–13);
2. **Доля несъеденного**, % (замер построчно по тарелкам, не «в среднем»);
3. **Доля жителей с реальным выбором** вчера, % (включая постельных — два варианта на подносе);
4. **Отказы от еды** за неделю, штук (эскалация к врачу по правилу трёх);
5. **Жалобы/пожелания по еде** в совете жителей, штук (еда — первая тема советов).

Формула доказательной базы: 126 записей в трёх реестрах (право 34 · клиника 48 · международные практики 44); в полном тексте процитировано 115 позиций; реестры с датами проверки — в репозитории.

Как говорить с учредителем

Идти не с просьбой о деньгах, а с числами и планом: (1) «вот наши семь дней замера — вот что мы теряем»; (2) «вот пилот на одном отделении, его бюджет — ноль или копейки»; (3) «вот что попросим, если пилот сработает: ставка/оборудование/строка контракта». Письмо о дефиците ресурсов — не индульгенция, а доказательство своевременного реагирования. Чек-лист разговора и десять вопросов учредителю — разделы 38–39 полного руководства.

Одна просьба

Не меняйте сразу всё меню. За семь дней измерьте реальность одного приёма пищи, затем запустите на одном отделении 90-дневный пилот с двумя безопасными вариантами и журналом фактического выбора. Три действия руководителя: (1) аудит одного обеда на этой неделе; (2) безопасный диапазон выбора — вместе с медицинской службой; (3) отделение для пилота и дата первого замера — назначены.

Полная версия: «Не просто накормить. Как организовать безопасное, достойное и вариативное питание людей с психическими нарушениями в домах социального обслуживания» (250 стр., разделы 1–44, приложения 1–45). Репозиторий: github.com/qlolp/seminar-variable-food-2026. Версия 1.2 — 21.08.2026.